



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Dermatología

¿Cuál de los siguientes factores NO se suele asociar a la aparición o empeoramiento de las lesiones de psoriasis?:

1. Tratamiento con litio.
2. Estrés emocional.
3. Calor y humedad.
4. Infecciones respiratorias de vías altas.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Del psoriasis es importante conocer: la clínica, su histología y el tratamiento, pero es aconsejable conocer algunos datos sobre su etiología, ya que es susceptible de ser preguntada, como en este caso, y suelen ser preguntas fáciles si al menos lo has leído una vez. Aparte de los factores genéticos relacionados con la aparición de psoriasis, encontramos factores ambientales que influyen en su desarrollo, como son: - infecciones. - Fármacos: litio, betabloqueantes, AINES, antipalúdicos - Traumatismos: fenómenos de Koebner. - Factores psicológicos (estrés). No son factores agravantes el calor, la humedad o la luz, ya que de hecho mejoran las lesiones del psoriasis. Por tanto, la opción incorrecta es la 3.

-----O-----

Una paciente de 56 años acude a la consulta refiriendo la aparición de unas lesiones sobreelevadas en cara, tórax y brazos, que le duelen "al mínimo roce con la ropa". Además, la paciente presenta una temperatura de 38,2 °C y dolores articulares. Dice que "no se encuentra bien, últimamente está más cansada y ha perdido peso". Con la sospecha clínica que usted tiene, decide administrar corticoides. Las lesiones responden rápidamente. ¿Cuál es el diagnóstico que sospecha usted?

1. Dermatomiositis.
2. Eritema necrolítico migratorio.
3. Síndrome de Sweet.
4. Signo de Lesser Trélat.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La descripción de las lesiones que presenta la paciente, junto a la fiebre y los dolores articulares conforman el cuadro clínico típico de un síndrome de Sweet (opción 3 correcta), que, recordemos, se asocia con frecuencia a la leucemia mieloide aguda (LMA). Debemos sospechar una dermatosis paraneoplásica cuando nos describan una lesión cutánea de reciente aparición en el contexto de un síndrome constitucional (pérdida de peso, astenia, malestar general, etc.).

-----O-----

Un paciente de 72 años, agricultor jubilado, presenta sobre el pómulo derecho una pápula de 2 cm de diámetro, de coloración rosada y brillo perlado. Refiere que comenzó como una pequeña lesión "hace ya muchos años" y ha ido creciendo lentamente hasta alcanzar el tamaño actual. Al examinarla de cerca, observamos que tiene telangiectasias en su superficie. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a

la lesión que con más probabilidad presenta el paciente:

1. El factor de riesgo más importante es la exposición solar crónica.
2. Pese a tratarse de una entidad maligna, su pronóstico es excelente.
3. Suele asentarse sobre una lesión premaligna previa.
4. Nunca aparece en mucosas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La descripción corresponde a un carcinoma basocelular: el tumor maligno más frecuente en la especie humana. Su principal factor etiológico es la exposición solar crónica, por lo que aparece con más frecuencia en zonas como cabeza, cuello, extremidades superiores... Como se expone en el enunciado de la pregunta, tiene aspecto de pápula rosada con brillo perlado y telangiectasias o glóbulos pigmentados en su interior. Su pronóstico es excelente debido a su lento crecimiento y a que se extiende por contigüidad, siendo excepcionales las metástasis a distancia. Suele originarse *de novo* sobre piel sana (RESPUESTA CORRECTA 3) y nunca aparece en mucosas.

-----O-----

Un niño de 12 años consulta en oftalmología por pérdida de agudeza visual en ojo derecho. En el fondo de ojo, el oftalmólogo descubre un hemangioblastoma retiniano. En la exploración física, además se objetiva hipertensión arterial. Analíticamente, destaca un HCTO del 58% y una Hb de 17 g/dL. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones sería esperable encontrar en la evolución de esta enfermedad?

1. Angiomatosis encefalotrigeminal.
2. Nódulos de Lisch.
3. Adenomas sebáceos de Pringle.
4. Tumores renales.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: La asociación con hipertensión, policitemia y otros tumores tipo hemangioblastoma cerebeloso (que justificaría la policitemia por secretar EPO) o Ca renal (que justificaría la HTA), así como hemangioblastoma retiniano (que suele ser la primera manifestación de la enfermedad, como este caso) es el cuadro típico de la enfermedad de Von Hippel-Lindau (angiomatosis cerebelo-retiniana). También son típicos de esta enfermedad los angiomas cutáneos. Recuerda que es una enfermedad autosómica dominante, que afecta al cromosoma 3.

-----O-----

Niño de 6 meses que es traído por su madre, que está asustada, porque presenta unas máculas marrón-rojizo en el tronco, y también en extremidades, que van apareciendo progresivamente en las últimas semanas. El estado general del niño es excelente. Ante la sospecha clínica, usted frota una de las lesiones, que se pone eritematosa y edematosa. Este niño padece un tipo de:

1. Urticaria.
2. Histiocitosis.

3. Mastocitosis.
4. Dermografismo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta cuyo detalle más sugestivo son las lesiones descritas, maculosas y marronáceas, que se vuelven eritematosas y pruriginosas en las zonas de roce. Lo que pretenden describirnos con esto es el famoso signo de Darier: eritema, edema y prurito tras el rascado de las lesiones. Recuerda que, aunque solo aparece en el 75% de las mastocitosis, se considera PATOGNOMÓNICO de esta enfermedad (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Ante una lesión sobreelevada con bordes perlados y telangiectasias en superficie, hemos de pensar que se trata de:

1. Queratoacantoma.
2. Epitelioma basocelular.
3. Melanoma amelanótico.
4. Queratosis seborreica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El carcinoma basocelular es importante dentro del capítulo de dermatología. Debes conocer bien sus características más importantes y los rasgos diferenciales con el carcinoma epidermoide. La clínica del basocelular es muy característica y no deberías haber tenido problemas para resolver esta pregunta. Se debe sospechar su existencia cuando estamos ante una pápula de aspecto blanquecino y brillo perlado, que crece progresivamente. A veces, puede ulcerarse en el centro, con formación sucesiva de costras. Es típica la aparición de alguna telangiectasia en su superficie (opción 2 correcta). En cambio, el carcinoma epidermoide o espinocelular tiene un aspecto diferente. Dado que se origina en células con cierto grado de maduración, es más monomorfo que el basocelular. Cursa como placas eritematosas o eritematodescamativas de larga evolución, que con el tiempo adoptan formas pápulo- tumorales, con frecuencia ulceradas y sangrantes.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la pitiriasis versicolor?

1. Es infrecuente su aparición en pecho y espalda.
2. Es característico el signo de la uña positiva.
3. Es una micosis relativamente infrecuente.
4. El microorganismo implicado con mayor frecuencia es *Trychophyton rubrum*.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que la Pitiriasis versicolor es producida por la *Pityrosporum ovale* (*Malassezia furfur*), siendo una micosis frecuente en pacientes jóvenes. Afecta a las zonas seborreicas (hombros, pecho y espalda), produciendo máculas hipercrómicas o hipocrómicas, no pruriginosas, que descaman al rascado si la infección está activa (signo de la uña positiva, que es característico), por lo que marcamos la opción 2

correcta.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece cierta respecto al nevus displásico?:

1. Es un nevus melanocítico adquirido juntural que suele aparecer después de la pubertad.
2. El riesgo de melanoma es igual de elevado, tanto en los casos esporádicos como en los familiares.
3. No es especialmente importante evitar la exposición a la luz ultravioleta, ya sea artificial o natural, pues ya hay cambios atípicos en estas lesiones que no se pueden evitar.
4. Es primordial educar a los pacientes en cuanto a las características clínicas incipientes del melanoma.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: Los nevus displásicos implican una mayor probabilidad de desarrollar un melanoma (aunque esta probabilidad es mucho mayor en los casos familiares), por lo que es importante la educación del paciente para que consulte precozmente en caso de encontrarse una lesión pigmentaria con las características siguientes:

- A: Asimetría.
- B: Bordes irregulares.
- C: Coloración no uniforme.
- D: Diámetro mayor de 5 mm.
- E: Evolución

Por supuesto, el diagnóstico de melanoma y nevus displásico es histológico y habría que confirmarlo con biopsia, pero estos datos son suficientes como screening.

-----O-----

Varón de 50 años con lesiones eritematoescamosas en la parte superior del cuerpo que confluyen, dejando zonas de piel sana en el interior, y tienen coloración amarillenta. Las palmas y plantas tienen placas queratósicas gruesas. En cara y cuero cabelludo existe descamación de la piel. Las lesiones elementales son pápulas queratósicas foliculares. ¿Qué sospecha usted?

1. Enfermedad de Darier.
2. Psoriasis.
3. Pitiriasis rubra *pilaris*.
4. Dermatitis seborreica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La pitiriasis *rubra pilaris* (respuesta 3 correcta) obedece a un trastorno de la queratinización, que se engloba dentro de las enfermedades eritematodescamativas. Puede ser adquirida o hereditaria autosómica dominante (en este caso, aparece en la infancia). Las características clínicas más importantes son:

- Placas descamativas anaranjadas, con islotes de piel normal dentro de ellas.
- Pápulas queratósicas foliculares en zonas de extensión.

Puede confundirse con la psoriasis, que es su principal diagnóstico diferencial. Para su tratamiento, se emplean queratolíticos y el acitretino. En alguna ocasión, responde a tratamiento con PUVA.

-----o-----

En la práctica clínica habitual, la toxicodermia es una entidad sobrediagnosticada. Su forma de presentación más frecuente consiste en exantema maculopapular morbiliforme (pues se parece al morbilivirus del sarampión). Con respecto a las toxicodermias, es FALSO que:

1. Antiinflamatorios, alopurinol, antibióticos, anticonceptivos y antiepilépticos son algunos de los fármacos más implicados en las toxicodermias.
2. El exantema fijo medicamentoso a menudo no se relaciona con fármacos.
3. La bleomicina y la ingesta de setas shiitake da una dermatitis flagelada.
4. Las quinolonas se han implicado fuertemente en la pustulosis exantemática aguda.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta tan sencilla como *a priori* aparenta, pues el exantema fijo medicamentoso se denomina así porque la mayoría (por no decir todos) ocurren por medicamentos (por cierto, al igual que la necrólisis epidérmica tóxica) (opción 2 falsa, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son verdaderas.

-----o-----

Un niño con lesiones vesiculosas en la boca, en las manos, y en los pies, tiene una infección por:

1. Coxsackie A16.
2. Parvovirus B19.
3. Rubéola.
4. Virus herpes 6.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta de dificultad intermedia perteneciente al bloque de enfermedades infecciosas en dermatología. La enfermedad mano- pie- boca, o también denominada glosopeda, es una patología producida por el virus Coxsackie A, en especial por el A16, que cursa con la aparición de un exantema vesiculoso que afecta a la mucosa oral, manos, pies y área del pañal. Puede ser generalizado. Por lo que marcamos la opción 1 correcta.

-----o-----

Una joven de 23 años ha presentado episodios de dolor abdominal y edema de los labios y lengua con el estrés. Ocasionalmente ha tenido junto a éstos edema de laringe. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada al afrontar este cuadro?:

1. Medir la concentración sérica de C1-inhibidor.

2. Prevenir los brotes con antihistamínicos sistémicos.
3. Estudiar posibles causas autoinmunes o neoplásicas antes de concluir el proceso diagnóstico.
4. Utilizar plasma fresco o C1-inhibidor como profilaxis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Aunque no sabemos si existen casos familiares similares, por la clínica y por la edad de la paciente es probable que se trate del angioedema hereditario (autosómico dominante) o edema angioneurótico familiar de Quincke. No obstante habría que tener en cuenta la posibilidad de que se trate de la forma adquirida y por ello habría que descartar posibles causas autoinmunes o neoplásicas.

El angioedema hereditario se caracteriza por la aparición de brotes de edema del tejido celular subcutáneo sobretodo en cara, manos y pies. No se acompaña de habones ni prurito. En algunos casos se produce afectación de la mucosa intestinal y respiratoria lo cual puede manifestarse en forma de vómitos, diarrea, dolor abdominal o broncoespasmos. El traumatismo tanto físico como psicológico puede desencadenar el cuadro. Opción 3 correcta.

Se debe a un déficit real o funcional del C1 inhibidor. El test de screening de elección es la determinación de los niveles de C4, si estos son bajos y la clínica es compatible, se debe proceder a la determinación del C1 inhibidor. Este proceso no responde a los antihistamínicos, epinefrina o corticoides. El tratamiento de las crisis agudas se hace con concentrados de C1 inhibidor o con plasma fresco congelado y la profilaxis con danazol o estanozolol.

-----o-----

Eczema es un término que designa un tipo de reacción inflamatoria cutánea a diferentes estímulos, y que puede clasificarse en distintos grupos. Señale la afirmación que le parece correcta en cuanto a este tema:

1. Los diferentes tipos de eczemas comparten básicamente las características clínicas, dependiendo los hallazgos histológicos de la etiopatogenia de cada una.
2. Los antihistamínicos, en especial los de segunda generación, son muy efectivos en el tratamiento de todos los eczemas.
3. El eczema alérgico de contacto es una reacción de hipersensibilidad tipo IV, por el contacto cutáneo o de las mucosas con una sustancia a la que el paciente está previamente sensibilizado.
4. Es raro que el eczema atópico se manifieste antes de los dos años de edad.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Tal como se explica en la respuesta 3, el eccema de contacto es una reacción de hipersensibilidad retardada. El resto de las opciones son falsas, por los motivos siguientes:

R1. La histología no depende del origen del eccema, sino de su evolución (agudo, subagudo, crónico).

R2. Los antihistamínicos son poco eficaces para el prurito del eccema. El tratamiento de elección son los esteroides tópicos.

R4. El níquel está implicado en eccemas alérgicos, no irritativos.

R5. El eccema atópico es muy frecuente en la infancia. De hecho, existe la llamada forma del lactante, bastante anterior a los dos años de edad.

Mujer de 46 años, de profesión secretaria. Como antecedentes destacan una úlcera duodenal correctamente tratada hace tres años y una depresión controlada con antidepresivos tricíclicos. Desde hace siete días presenta lesiones papulosas, foliculares y queratósicas que asientan sobre una base eritematosa. Además, existe una queratodermia palmoplantar importante. El eritema tiene un tono amarillo anaranjado. El cuero cabelludo también se encuentra afectado. Con respecto a la enfermedad que presenta esta paciente, es FALSO que:

1. Puede presentar fenómeno de Koebner.
2. A menudo existen zonas de piel sana entre las placas afectas.
3. El etretinato mejora la enfermedad, pero no acorta el curso clínico.
4. La forma circunscrita afecta al 25% de los casos y es típica de los adultos.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La pitiriasis *rubra pilaris* obedece a un trastorno de la queratinización que se engloba dentro de las enfermedades eritemato descamativas; puede ser adquirida o hereditaria autosómica dominante (en este caso, aparece en la infancia) (opción 4 falsa, por lo que la marcamos). Las características clínicas más importantes son:

- Placas descamativas anaranjadas, con islotes de piel normal dentro de ellas.
- Pápulas queratósicas foliculares en zonas de extensión.

Puede confundirse con la psoriasis, que es su principal diagnóstico diferencial. Para su tratamiento se emplean queratolíticos y el acitretino. En alguna ocasión, responde a tratamiento con PUVA.

Entre las siguientes, indique aquella enfermedad en que la alopecia NO es cicatricial:

1. Alopecia areata.
2. Liquen plano.
3. Sarcoidosis.
4. Mucinosi folicular.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las alopecias cicatrizales se caracterizan por la sustitución de la unidad pilosebácea por tejido fibroso, por tanto estas alopecias son permanentes. Se dividen en dos grupos. El primero de ellos son las alopecias cicatrizales primarias cuya etiología es desconocida. El otro corresponde a las alopecias cicatrizales secundarias, que pueden deberse a procesos infiltrativos (metástasis), traumatismos (quemaduras, radioterapia) e infecciones. Todas las opciones corresponden a procesos que pueden producir alopecia cicatrizal salvo la alopecia areata que es una alopecia no cicatrizal, presumiblemente autoinmune, por lo que marcamos la opción 1 correcta.

Mujer de 40 años, peluquera de profesión, presenta desde hace años hiperqueratosis

subungueal en uñas de dedos y pies. Desde hace 3 semanas refiere aparición de lesiones tipo placas, asintomáticas en codos y región glútea. Las placas desprenden escamas nacaradas tras el rascado. Señale la FALSA respecto a su enfermedad:

1. Pueden presentar anemia y niveles disminuidos de folatos.
2. En casos severos es frecuente la hipoalbuminemia.
3. Las uñas de las manos se encuentran afectadas en un 10% de los pacientes.
4. La decoloración ungueal en mancha de aceite es característica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El caso clínico describe una paciente con psoriasis: placas en codos y rodillas, descamativas con escamas nacaradas, por lo que no deberías tener dudas en cuanto a la entidad que se trata.

En cuanto a la pregunta en cuestión es algo más compleja.

En este caso la opción correcta (respuesta FALSA es la 3). La afectación ungueal por psoriasis se describe entre un 10-70% de los pacientes con psoriasis, siendo más frecuente la afectación ungueal de las manos que la de los pies. No por tanto un 10% como afirma la respuesta.

Las manifestaciones pueden variar desde distrofias ungueales, oil spots o mancha en aceite como la más característica (opción 4 verdadera), y pits como las más típicas.

Respecto a la opción 1) y 2), recuerda que en el psoriasis existe un metabolismo aumentado por lo que es posible que se produzca hipoalbuminemia, además de anemia y disminución de folatos.

-----O-----

La dermatitis de los prados está producida por:

1. Contacto con plantas que contienen furocumarinas.
2. Contacto con ortigas.
3. Contacto con ácaros de los prados.
4. Contacto con cantáridas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La dermatitis de los prados es un tipo de dermatitis fototóxica y por tanto suele ocurrir con la primera exposición a la sustancia fotosensibilizante (cuando se encuentra sobre la piel en la concentración adecuada) si después va seguida de una exposición solar. No es necesaria la sensibilización previa. Las lesiones cutáneas aparecen a las pocas horas de la exposición solar y se localizan en las zonas fotoexpuestas. Las sustancias en las plantas responsables de esta reacción son las furocumarinas (opción 1 correcta), por su capacidad de absorber radiación lumínica y así causar fototoxicidad. Clínicamente consiste en la aparición de líneas y formas raras, eritematoedematosas, con vesículas y ampollas que cuando se resuelven dejan una hiperpigmentación postinflamatoria residual. El síntoma habitual suele ser una sensación de quemazón. El tratamiento depende de la intensidad del proceso y es similar al de cualquier eccema. La loción de calamina puede resultar de utilidad.

-----O-----

Acude a urgencias un paciente que, tras sufrir un pinchazo cortando unos rosales plantados en su jardín hace unos días, le ha aparecido fiebre junto con una pequeña

úlceras en la zona del pinchazo, asociada a una inflamación linfática que sigue un trayecto hacia proximal. ¿Cuál ha sido el agente responsable del cuadro?

1. *Erysipelothrix rhusiopathiae*
2. *Sporothrix schenckii*
3. *Tricophyton rubrum*
4. *Tricophyton schoenleinii*

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata de una esporotricosis causada por *Sporothrix schenckii* como consecuencia, generalmente, de un pinchazo con un rosal. Se trata de un hongo que se encuentra en maderas y vegetales con espinas causando el cuadro descrito en el enunciado (nódulo que se ulcera + linfangitis). Opción 2 correcta.

Erysipelothrix causa una afectación llamada erisipeloide, típica de carniceros o tras clavarse una espina de pescado, cuya manifestación es parecida a la descrita, pero los antecedentes serían diferentes.

Las opciones 3 y 4 hacen referencia a diferentes gérmenes causantes de dermatofitosis o tiñas.

-----O-----
¿Cuál sería el diagnóstico MÁS probable ante la aparición de una pápula color carne, bien delimitada, blanda y grasienta al tacto, en la región pectoral de un paciente de 53 años?

1. Verruga vulgar.
2. Queratosis seborreica.
3. Xantoma eruptivo.
4. Queratoacantoma en fase inicial.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta cuya descripción dermatológica del enunciado no es demasiado afortunada; aun así, la pregunta se puede contestar sin problemas. Las queratosis seborreicas son tumores benignos de la piel sumamente comunes. De hecho, se puede decir que cualquier persona desarrollará una a lo largo de su vida. Solo con este dato, se podría contestar la pregunta, porque la queratosis seborreica es muchísimo más prevalente que el resto de opciones. Más claves para contestar adecuadamente serían la edad (típicamente, se da en pacientes mayores de 40 años) y la localización (el tronco es un lugar muy frecuente). Se les da el nombre de “seborreicas” por su aspecto, pero no tienen nada que ver con las glándulas sebáceas. Muestran una topografía verrucosa, con múltiples folículos obturados y arborescencias (de ahí que en el enunciado te hablen de “grasienta o untuosa al tacto”) (respuesta 2 correcta). Las verrugas vulgares son pápulas ásperas, escamosas y espinosas (no blandas). Lo más frecuente es que se presenten en las manos. El quiste epidérmico, como su nombre indica, se presenta como un tumor sólido intradérmico (no se trata de una pápula). Los veremos como una protuberancia de la piel en forma de cúpula. Los xantomas son lesiones infrecuentes que se producen como consecuencia de alteraciones en el metabolismo de las grasas. Característicamente, presentan un color amarillento (no color carne). En concreto, los xantomas eruptivos son lesiones múltiples, características de la hiperquilomicronemia severa. El queratoacantoma es un tumor benigno que, en su mayoría, se localiza en piel expuesta al sol (por tanto, no en el área pectoral). Su apariencia y descripción es muy característica: nódulo cupuliforme con cráter queratósico central. La mayoría de los queratoacantomas regresan de forma espontánea.

Un hombre de 74 años acude a su consulta por presentar síndrome constitucional con pérdida de 5 kg de peso en el último mes, junto a astenia. Refiere que en las tres últimas semanas, además, ha observado la aparición de lesiones rojizas en piernas que en ocasiones drenan un material oleoso, asociándose también dolor abdominal y costal, así como dolor y rubor en tobillos y rodillas. Usted decide realizar una biopsia y observa que en el tejido celular subcutáneo aparecen células fantasma. Las manifestaciones clínicas del paciente y este hallazgo de la biopsia cutánea le llevará a realizar una de las siguientes pruebas para hacer el diagnóstico definitivo:

1. Endoscopia digestiva: adenocarcinoma gástrico.
2. TC abdominal: cáncer de páncreas.
3. TC torácico: sarcoidosis ganglionar (síndrome de Löfgren).
4. Cultivo de los nódulos cutáneos: tuberculosis cutánea (lupus vulgar).

Resp. Correcta: 2

Comentario: Quizás esta pregunta a priori puede presentar mayor dificultad. Requiere realizar conexión de más de un tema del manual y reflexionar un poco sobre el caso, pero si se hace esto con tranquilidad se trata de una pregunta asequible. En primer lugar la pregunta te deja claro que el paciente presenta un síndrome constitucional y eso sumado a lesiones cutáneas, ante la duda es un síndrome paraneoplásico. Es cierto que no nos hablan de pápulo vesículas de distribución periorificial, hiperglucemia, glositis, que nos podrían orientar a un glucagonoma, tal y como solemos identificarlo, en este caso las pistas son más sutiles. Nos hablan de "lesiones rojizas" que drenan un material oleoso. Nos están hablando de nódulos, concretamente (como casi siempre que tenemos nódulos en piernas) de una paniculitis. Fíjate además que en la biopsia te hablan de que la lesión se centra en el "tejido celular subcutáneo". Sabemos que existen las paniculitis pancreáticas, sabemos además que en las paniculitis hay inflamación de los adipocitos y por último sabemos que el páncreas participa en la digestión de la grasa. En estos casos, concretamente se cree que la liberación de enzimas pancreáticos (amilasa, lipasa, fosforilasa y tripsina) junto a un aumento de la permeabilidad de la microcirculación permite la entrada de esas enzimas en los lóbulos pancreáticos, con la consiguiente hidrólisis de la grasa y formación de glicerol y ácidos grasos libres, que conducirían a la necrosis grasa e inflamación, produciendo por tanto zonas de degeneración de los adipocitos (que aparecen como células anucleadas con una membrana gruesa conocidas como "células fantasma"). Además pueden presentarse artralgias y artritis con poliserositis por extensión de la necrosis enzimática a esas localizaciones (La inflamación articular del paciente). Como última pista teníamos el dolor, abdominal e irradiado a costal. Recuerda que las paniculitis pancreáticas por tanto pueden presentarse de manera secundaria (como paraneoplasia) a un cáncer de páncreas, siendo el más frecuente el carcinoma de células acinares, por lo que marcamos la opción 2 correcta.

¿Cuál de las siguientes hechos le haría plantearse como poco probable un diagnóstico de toxicodermia?

1. Una puntuación alta en el algoritmo de Naranjo.
2. Reaparición del efecto tras reintroducción del fármaco.

3. Desaparición del efecto tras la retirada del fármaco.
4. Una puntuación baja en el algoritmo de Karch Lasagna.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta atípica y probablemente más de farmacología que de Dermatología.

Aun así, es muy cierto que los dermatólogos utilizan algoritmos como los de Naranjo o Karch Lasagna para plantear la probabilidad de un diagnóstico de toxicodermia. No debes conocerlos en profundidad, pero si saber que incluyen criterios como:

- Secuencia temporal razonable.
 - Conocimiento previo de la reacción adversa.
 - Mejora del efecto tras la retirada del fármaco.
 - Reaparición del efecto tras reintroducción del fármaco.
- Evidentemente cuanto mayor es la puntuación, más probable es que el fármaco sospechoso, sea el responsable, por lo que marcamos la opción 4 correcta.

-----O-----

Varón de 82 años que presentaba como antecedentes personales una diabetes tipo II, con control dietético, hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca hipertensiva, e insuficiencia venosa en ambos miembros inferiores, que acude a la consulta para consultar por la aparición de una placa en el tercio medio de la tibia derecha, de 12 cm de longitud, con 9 cm de ancho en su parte más ancho y 6 cm en su parte más estrecha, de características papulosas, de color cerúleo, y áreas purpúricas que confluyen. Presenta en ambas piernas edema con fóvea. Se le realiza un estudio histológico de la lesión, que expone como resultado atrofia epidérmica, cambios propios del éxtasis venoso, presencia de mucoblastos y depósitos de un material mucinoso a nivel dérmico. La mucinosis pretibial CASI SIEMPRE se asocia a:

1. Porfiria cutánea tarda.
2. Síndrome de Cushing.
3. Hipertiroidismo.
4. Hiperparatiroidismo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla que no debemos fallar. La lesión cutánea más característica de la enfermedad de Graves es el mixedema pretibial, también llamada dermatopatía tiroidea, provocada por depósito de mucopolisacáridos en la dermis. Clínicamente, se manifiesta como placas rosado-marrónáceas que suelen localizarse en cara anterior de las piernas o en el dorso de los pies. Estas lesiones evolucionan de forma independiente respecto a los niveles de las hormonas tiroideas, pudiendo persistir, aunque los mismos se normalicen. Otras alteraciones cutáneas frecuentes en el hipertiroidismo son el eritema facial, palmar y de los codos, debido a

la vasodilatación periférica, hiperhidrosis, alopecia difusa y deformación cóncava de las uñas con onicólisis distal (uñas de Plummer) por lo que marcamos la opción 3 correcta.

El hipotiroidismo presenta, como alteración dermatológica más típica, el mixedema generalizado, que no debemos confundir con el mixedema pretibial antes descrito, pues, aunque ambos cursen con acúmulo dérmico de mucopolisacáridos, en el caso del hipotiroidismo las lesiones no se presentan de forma tan localizada y definida, sino que se manifiesta como piel edematosa, pálida y seca, notándose principalmente estos signos a nivel facial (cara inexpresiva, párpados edematosos, macroglosia, etc.).

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para el melanoma?

1. Radiación ultravioleta.
2. Nevus atípicos.
3. Espesor de la lesión medido en milímetros.
4. Mas de 50 nevus comunes.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta sencilla si se lee con atención. Recuerda los factores de riesgo para melanoma: la radiación ultravioleta (sobre todo quemaduras intensas en la infancia y adolescencia), el fototipo I y II, >50-100 nevus comunes, AP o AF de melanoma, nevus congénitos, (sobre todo gigantes) y nevus atípicos. El espesor del melanoma medido en milímetros es el índice de Breslow, que es el factor pronóstico mas importante pero no factor de riesgo (respuesta 3 falsa).

La dermatosis precancerosa MÁS frecuente es:

1. Queratosis actínica.
2. Nevus organoide o de Jadassohn.
3. Leucoplasia.
4. Xeroderma pigmentoso.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Recuerda que la queratosis actínica se relaciona con la foto-exposición y por eso se dará en zonas expuestas al sol. Son lesiones máculo-papulosas eritemato-descamativas que en un elevado porcentaje acaban desarrollando un carcinoma epidermoide. Son las lesiones precancerosas más frecuentes y por ello la opción 1 es correcta.

Señale la opción falsa con respecto al grupo de las toxicodermias:

1. El Síndrome de Dress es una toxicodermia con un 10% de mortalidad en la cual hay alteración de transaminasas, eosinofilia y síntomas sistémicos.
2. El exantema morbiliforme, es una reacción cutánea adversa severa y constituye la forma de toxicodermia mas frecuente.
3. La pustulosis exantemática aguda generalizada es una toxicodermia cuya mortalidad llega al 5% de los casos. A menudo se implican antibióticos en su etiología.

4. El síndrome de Steven Johnson presenta una mortalidad del 5 al 15%, y en algunos casos se ha implicado el mycoplasma pneumoniae.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las reacciones adversas cutáneas a fármacos son un problema frecuente que afecta al 3% de los pacientes hospitalizados. Afortunadamente solo el 2% de esas toxicodermias se consideran graves. El espectro de esas reacciones adversas cutáneas graves incluye patologías como la pustulosas exantemáticas agudas generalizadas (PEGA), la reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (acrónimo en inglés, DRESS), el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET) (en este orden aproximado de gravedad). El exantema morbiliforme es la forma de toxicodermia mas frecuente, pero no se incluye en este espectro de reacciones cutáneas adversas severas (opción 2 falsa).

-----o-----

Varón de 60 años, con placas infiltradas (de aparición progresiva) en cuero cabelludo que dejan alopecia cicatricial. El informe anatomopatológico da como resultado alopecia mucinosa. ¿A qué se asocia esta dermatosis paraneoplásica?

1. Carcinoma de mama.
2. Linfomas cutáneos de células T.
3. Adenocarcinoma del tubo digestivo.
4. Carcinoma de pulmón.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil y específica. La alopecia mucinosa (mucinosi folicular) es una enfermedad de la unidad pilosebácea que se presenta en la clínica como pápulas o placas foliculares descamativas agrupadas, con pérdida de pelo asociada. Está causada por la infiltración mucinosa de las glándulas sebáceas y la vaina externa del folículo pilosebáceo, y afecta habitualmente al cuero cabelludo, cara y cuello. Puede ser primaria (idiopática) o secundaria a otras enfermedades, como la micosis fungoide (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Varón de 60 años, agricultor. En tercio medio de labio inferior presenta una infiltración de 0,5 cm, recubierta de costra blanquecina y cuya evolución es de un año. Te sugiere el diagnóstico de:

1. Queratoacantoma.
2. Carcinoma espinocelular.
3. Papiloma oral.
4. Leucoplasia ulcerans.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Dado que estamos ante un tumor de la semimucosa labial, difícilmente puede tratarse de un basalioma, que por definición no aparece en mucosas. Sin embargo, teniendo en cuenta la exposición solar crónica (agricultor) y la morfología lesional (lesión costrosa, infiltrada y de larga evolución), el diagnóstico más

probable es un carcinoma epidermoide. Recuerda que, en estos casos, el rico drenaje linfático del labio inferior hace que sea más probable la diseminación linfática. Opción 2 correcta.

Varón de 60 años de edad, viudo, carpintero hasta hace 1 mes, momento en el que decide dedicarse a la albañilería. Antecedentes familiares de atopía. Diabetes no insulín dependiente mal controlada desde hace 5 años. Gastrectomizado por úlcus gástrico hace 30 años. Desde hace 3 días presenta lesiones eritematosas, vesiculosas, de bordes mal definidos y localizadas en el dorso de las manos, los antebrazos y la región facial. Estas lesiones son, además, muy pruriginosas. Con respecto a esta patología señale la cierta:

1. Dada la localización, hay que pensar en una atopía del adulto.
2. Parece una patomimia pues probablemente no esté contento con su nuevo trabajo.
3. El empleo de corticoides y antihistamínicos tópicos mejorarán rápidamente el cuadro.
4. Probablemente el cromo esté implicado en la patogenia del proceso.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La clínica del proceso que padece este varón (prurito, lesiones eritematosas, vesiculosas, de bordes mal definidos), junto con la localización de las lesiones y su actual profesión, deben sugerirnos el diagnóstico de eccema de contacto (dermatitis debida a sustancias que entran en contacto con la piel), concretamente el eccema de contacto alérgico. Este es el que aparece en las personas que se han sensibilizado a un determinado producto químico. Como requiere sensibilización, este eccema no aparece en la primera exposición con el alérgeno y además puede aparecer también en zonas distantes a las del contacto. Los casos profesionales frecuentemente muestran afectación en el dorso de las manos. En este paciente lo más probable es que exista una sensibilización al cromo. Este es el alérgeno más frecuente en los varones y se encuentra en el cemento (albañilería) y también en los calzados de cuero y la bisutería por lo que marcamos la opción 4 correcta. El diagnóstico de confirmación se realiza con las pruebas epicutáneas o patch tests (en este caso el cromo daría positivo). El tratamiento consiste en eliminar el alérgeno y en la administración de antihistamínicos vía oral y corticoides tópicos y/o sistémicos, según la intensidad y extensión del proceso.

El angioedema hereditario está en relación con:

1. Bajos niveles de properdina.
2. Altos niveles de properdina.
3. Bajos niveles de inhibidor de C1.
4. Altos niveles de hemoglobina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El angioedema hereditario o edema angioneurótico familiar de Quincke se caracteriza por la aparición de brotes de edema del tejido celular subcutáneo sobre todo en cara, manos y pies. No se acompaña de habones ni prurito. En algunos casos se produce afectación de la mucosa intestinal y respiratoria lo cual puede manifestarse en forma de vómitos, diarrea o broncoespasmos. Se debe a un déficit real o funcional del C1 inhibidor y se hereda de forma autosómico dominante, por lo que marcamos la opción 3 correcta. Existen también formas adquiridas con una clínica similar pero de comienzo más tardío. El tratamiento de las crisis agudas se hace con concentrados de C1 inhibidor o con plasma fresco congelado y la profilaxis con danazol o estanozolol. El ácido tranexámico, un fármaco antifibrinolítico, se ha utilizado

para el tratamiento de la forma aguda y crónica de la enfermedad con menos efectos secundarios.

Mujer embarazada presenta prurito, habiendo sido diagnosticado el marido de sarna hace tres semanas. ¿Cuál sería su actitud terapéutica?:

1. Tratar a ambos con lindane más las medidas higiénicas habituales.
2. Tratar a la embarazada con azufre al 5% en vaselina o permetrina y de nuevo al marido con permetrina o lindane más medidas higiénicas habituales.
3. Tratar al marido con lindane y corticoides y a la mujer con ivermectina.
4. Medidas higiénicas habituales y crotamitón a ambos.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El tratamiento de la sarna es un tema preguntable. El lindano ha sido el tratamiento de elección clásico de la escabiosis, pero no se puede usar en niños/embarazadas por ser neurotóxico, en estos casos se usaba vaselina azufrada). La permetrina se ha convertido en el tratamiento de elección ya que es mucho menos tóxica y se puede usar en niños/embarazadas. El crotamitón es otro ectoparasiticida, pero que tampoco se puede usar en el niños/embarazadas. La ivermectina oral es un excelente escabicida (de elección en brotes epidemiológicos), pero no debe usarse en embarazadas. Así pues, de las opciones presentadas sólo es correcta la opción 2. Es importante tomar en cuenta las medidas higiénicas que hay que hacer con respecto al hogar, vestimenta, ropa de cama, etc, que son claves para eliminar reservorios y disminuir la tasa de reinfestación.

Un caballero de 73 años acude a una revisión de rutina de su tensión arterial. Es un ejecutivo jubilado que, aparte de su ligera hipertensión, se encuentra sano y practica deporte. Tras la exploración, mientras se está vistiendo, comenta al médico que su mujer le ha estado insistiendo para que le enseñe un pequeño "grano" que tiene en la nariz. Él está seguro de que esta lesión, que lleva presente varios años, no tiene importancia. El médico anota en la historia: "pequeña pápula translúcida y endurecida, con algunas telangiectasias y su zona central deprimida". El diagnóstico más probable de esta lesión es:

1. Nevus displásico.
2. Acanthoma de células claras.
3. Xantoma eruptivo.
4. Basalioma.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El epiteloma basocelular es importante dentro del capítulo de dermatología. Debes conocer bien sus características más importantes y los rasgos diferenciales con el carcinoma epidermoide. La clínica del basocelular es muy característica y no deberías haber tenido problemas para resolver esta pregunta. Se debe sospechar su existencia cuando estamos ante una pápula de aspecto blanquecino y brillo perlado, que crece progresivamente. A veces, puede ulcerarse en el centro, con formación sucesiva de costras. Es típica la aparición de alguna telangiectasia en su superficie (opción 4 correcta). En cambio, el carcinoma epidermoide o espinocelular tiene un aspecto diferente. Dado que se origina en células con cierto grado de maduración, es más monomorfo que el basocelular. Cursa como placas eritematosas o eritematodescamativas de larga evolución, que con el tiempo adoptan formas pápulo- tumorales, con frecuencia ulceradas y sangrantes.

-----O-----

La brimonidina tópica es un vasoconstrictor empleado en la rosácea. Su uso tiene especial sentido en un tipo concreto de rosácea.

1. Rosácea ocular
2. Rosácea eritemato-telangiectásica
3. Rosácea fimatosa
4. Rosácea vasodilatada

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta poco rentable sobre un tema poco preguntado, el tratamiento de la rosácea. La brimonidina es un tratamiento tópico que tiene el especial efecto de producir una potente vasoconstricción. Está especialmente pensado para las formas eritemato-telangiectásicas por lo que marcamos la opción 2 correcta.

-----O-----

Un niño de 8 años tiene febrícula, malestar y una lesión cutánea dolorosa en el área submandibular que consiste en un nódulo duro a la palpación, ulcerado en su zona central y que excreta un material necrótico amarillento al ser comprimido. Se toman muestras para cultivo y biopsia, y éstas demuestran infiltrado granulomatoso en el que crece *Mycobacterium scrofulaceum*. El tratamiento inicial más adecuado será:

1. Observación hasta que lleguen los resultados de antibiograma.
2. Escisión quirúrgica de la lesión.
3. Rifampicina, isoniacida y etambutol.
4. Estreptomycin, isoniacida y pirazinamida.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta un tanto difícil. El caso se refiere a un escrofuloderma. Esto es una exteriorización a la piel de una infección micobacteriana desde un foco profundo (ej: pulmonar, ganglionar). En los adultos suele ser producida por el *M tuberculosis*, pero en niños suele ser responsable el *M scrofulaceum* o el *M avium*, pertenecientes a las micobacterias atípicas. En estos casos el tratamiento de elección sería el quirúrgico (opción 2 correcta).

-----O-----

La alopecia areata es frecuente en todas EXCEPTO en una de las siguientes enfermedades:

1. Síndrome de Down.
2. Anemia perniciosa.
3. Enfermedad de Addison.
4. Hipotiroidismo yatrogénico.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La alopecia areata es una alopecia no cicatrizal, presumiblemente autoinmune. Lo habitual es que esta enfermedad se presente de forma aislada. Sin embargo existe mayor incidencia en pacientes con dermatitis atópica, síndrome de Down, liquen plano, y ciertas enfermedades autoinmunes como son el lupus

eritematoso sistémico, tiroiditis, miastenia gravis, vitíligo, enfermedad inflamatoria intestinal, anemia perniciosa, artritis reumatoide, polimialgia reumática y síndrome de poliendocrinopatía autoinmune tipo 1. Por tanto, es más frecuente en todas las opciones excepto en el hipotiroidismo iatrogénico. Opción 4 correcta.

-----O-----

La presencia de nódulos subcutáneos rojos e indolores en la cara posterior de las extremidades inferiores se asocia a:

1. Tuberculosis.
2. Fiebre mediterránea familiar.
3. Enfermedad de Whipple.
4. Artritis reumatoide.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta es muy típica y no debe fallarse. El enunciado describe lo que parece ser una vasculitis nodular (paniculitis lobulillar con vasculitis); este cuadro puede asociarse a una tuberculosis, y entonces recibe el nombre de eritema indurado de Bazin, atribuyéndose en este caso las lesiones a un fenómeno de hipersensibilidad, y apareciendo en la biopsia granulomas tuberculoides con caseosis y necrosis grasa, acompañados de una vasculitis que afecta a arterias o venas lobulillares, por lo que marcamos la opción 1 correcta.

-----O-----

¿Cuál de las siguiente relaciones antígeno - enfermedad ampollosa es FALSA?

1. Desmogleina 1 y 3 - Penfigo Vulgar
2. BP 180 - Penfigoide Ampolloso
3. Desmocolina 1 - Penfigo Ig A
4. Transglutaminasa epidérmica - Herpes gestationis

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta más o menos sencilla sobre las enfermedades ampollas autoinmunes. Aunque los antígenos no sean un tema muy preguntado, deberías haber reconocido que el "transglutaminasa epidérmica" es típico de la Dermatitis Herpetiforme o Enfermedad de Duhring broq. Opción 4 correcta.

El resto de antígenos si son correctos. Aquí tienes un pequeño resumen (sin ser exhaustivos) que no debes memorizar. Es suficiente con que conozcas los del pénfigo vulgar y en todo casos los del penfigoide.

- Desmogleina 1 = Pénfigo Foliaceo
- Desmogleina 1 y 3 = Pénfigo Vulgar
- BP 180 y BP 230 = Penfigoide Ampolloso
- BP 180 = Penfigoide Gestacional
- Transglutaminasa epidérmica = Dermatitis herpetiforme
- Desmocolina 1 = Pénfigo IgA

Identifique la opción falsa de las siguientes asociaciones:

1. Prurito y ampollas tensas en el anciano- penfigoide ampolloso.
2. Dermatitis Ig A lineal – Sulfona.
3. Erosiones orales y acrales – pénfigo paraneoplásico.
4. Enfermedad de Duhring- Brocq – corticoides orales.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla si conocemos que la Enfermedad de Duhring-Brocq es la dermatitis herpetiforme y su manejo con sulfona (dapsona) + dieta estricta sin gluten (opción 4 falsa). El resto de opciones son correctas. Recuerda que la dermatosis con Ig A lineal es la enfermedad ampollosa autoinmune mas frecuente en la infancia y que a pesar de tener carácter autolimitado puede requerirse el uso de sulfona (fármaco que inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos y puede generar anemia hemolítica importante en pacientes con déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa).

NO es causa de "efluvio telogénico":

1. Parto o cirugía previos.
2. Tratamiento con citostáticos.
3. Fiebre alta o infección severa.
4. Endocrinopatías.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El efluviio telogénico consiste en una caída difusa del pelo del cuero cabelludo. Se produce tras ciertas situaciones que suponen un estrés físico o psicológico importante como pueden ser una enfermedad severa, fiebre, parto, cirugía, tracción del cabello etc. Existen algunos fármacos que pueden inducir un efluviio telogénico como son anfetaminas, ácido aminosalicílico, bromocriptina, captopril, cumarinas, carbamazepina, cimetidina, danazol, enalapril, etretinato, carbonato de litio, levodopa, metirapona, metoprolol, propranolol, piridostigmina y trimetadiona. Otras posibles causas son dietas severas, kwashiorkor, hipotiroidismo y diálisis renal con hipervitaminosis A secundaria. Tras estos estímulos, se produce una detención de la fase de crecimiento activo del ciclo folicular. La región inferior del folículo piloso sufre apoptosis y se desplaza hacia el nivel de la inserción del músculo erector del pelo. La caída del pelo ocurre desde 3- 5 semanas hasta 4 meses después del factor desencadenante. Este proceso suele ser autolimitado y se recupera espontáneamente. Los citostáticos suelen producir un efluviio anagénico, por lo que marcamos la opción 2 correcta.

El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmune producida por la presencia de autoanticuerpos contra anticuerpos de unión de los queratinocitos, concretamente frente a la desmogleina 3. Se trata de una enfermedad grave, que en el pasado tenía una elevada tasa de mortalidad. A día de hoy disponemos de múltiples tratamientos que han conseguido reducir dicha tasa. ¿Para cuál de los siguientes sería conveniente

solicitar el nivel de TPMT (tiopurina metiltransferasa)?

1. Rituximab.
2. Ciclosporina.
3. Azatioprina.
4. Micofenolato de mofetil.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta concreta sobre el tratamiento de los pénfigos y de muchas otras enfermedades autoinmunes. Opción 3 correcta: La azatioprina es un profármaco, emparentado con la 6-mercaptopurina. Ambas se suelen denominar conjuntamente tiopurinas, y se usan como agentes inmunosupresores. Los individuos con déficit hereditario de la enzima tiopurina metiltransferasa (TPMT) o tomando fármacos que la disminuyen, presentan una exagerada sensibilidad al efecto mielosupresor de la azatioprina. Si los niveles de tiopurina metiltransferasa son inferiores a 5 unidades, no debe emplearse el fármaco a menos que un médico lo indique con causa muy justificada.

Todas las siguientes dermatosis suelen manifestarse preferentemente en áreas de extensión de extremidades EXCEPTO una. Señale cuál:

1. Dermatitis herpetiforme.
2. Hiperqueratosis epidermolítica
3. Psoriasis.
4. Ictiosis vulgar.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta muy difícil que requiere consulta en libros especializados. La dermatitis herpetiforme es una erupción polimorfa de pápulas, placas eritematosas y vesículas muy pruriginosas cuya distribución es muy característica con agrupación en codos, rodillas, nalgas, hombros y cuero cabelludo. El psoriasis afecta en su forma más habitual, el psoriasis vulgar, a codos y rodillas. El eritema elevatum diutinum es una vasculitis leucocitoclásica de curso crónico que se caracteriza por la aparición de pápulas y placas eritematovioláceas en superficie de extensión de extremidades. La ictiosis vulgar se presenta como una descamación extensa de la piel de intensidad variable que respeta las flexuras y es más acentuada en las superficies de extensión, principalmente en las piernas. La opción 2 es la respuesta correcta, la hiperqueratosis epidermolítica o eritrodermia ictiosiforme ampular provoca eritema y descamación generalizada en pliegues de flexión y ampollas en áreas sometidas a traumatismos que dan lugar a erosiones.

¿Cuál de los siguientes tratamientos tópicos del acné polimorfo juvenil NO está indicado?

1. Peróxido de benzoilo.
2. Ácido retinoico.
3. Dipropionato de betametasona.
4. Ácido salicílico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En el tratamiento del acné se emplean antibióticos tópicos (eritromicina, clindamicina) e incluso sistémicos (tetraciclinas). También pueden ser beneficiosas ciertas sustancias queratolíticas, como el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo (este último, además, es comedolítico y bacteriostático). Los retinoides tópicos también tienen un papel, por su carácter comedolítico y exfoliante. Sin embargo, lo que no tiene sentido es tratar el acné con corticoides, precisamente porque ellos mismos pueden producir acné (acné esteroideo).
Opción 3 correcta.

-----o-----

Paciente de 75 años que consulta por una mácula pigmentada heterocroma, de contorno irregular, de unos 2 x 3 cm de diámetro, localizada en mejilla derecha, que ha experimentando un crecimiento muy lento en los últimos años. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Melanoma lentiginoso acral.
2. Lentigo maligno.
3. Nevus de Ota.
4. Eritema fijo pigmentario.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Ante una mácula pigmentada de contorno irregular que va creciendo de forma progresiva, evidentemente debemos pensar en una lesión tumoral maligna. De las opciones que te plantean, rápidamente debes descartar la opción 1, ya que nos dicen que el paciente la presenta en la mejilla. La opción 3 también tiene poco sentido, ya que se trata de una lesión benigna que se presenta en sujetos jóvenes en zonas inervadas por la 1ª y 2ª rama del trigémino, y afecta casi siempre al ojo. Menos sentido tiene la opción 4, ya que se trata de una lesión que no presenta las características clínicas que te explican en el enunciado, y además es una toxicodermia, y en el enunciado no te hablan en ningún momento del antecedente de la toma de un fármaco. La descripción clínica del tumor coincide de forma prácticamente literal con la que te hacemos en el Manual (Tema 24. Melanoma Maligno) para el lentigo maligno- melanoma. Es un tumor que aparece en personas de edad avanzada (75 años), que se caracteriza por una mancha pardonegruzca discrómica, de bordes irregulares, que crece de forma lenta, en cuestión de años. Por lo explicado en el Manual y por lo visto en clase, no debe haber ninguna duda en que el diagnóstico correcto es el lentigo maligno por lo que marcamos la opción 2 correcta.

-----o-----

Cuál de las siguientes células NO se encuentra en la epidermis:

1. Célula de Langerhans.
2. Célula de Merkel.
3. Fibroblasto.
4. Queratinocito.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta de formulación directa que se responde con conocimientos básicos y sin necesidad de estudio sin dificultad la opción 3, el fibroblasto, célula fundamental del tejido conectivo, por tanto no de un epitelio como la piel. Las otras opciones muestran las diversas células que la componen, el queratinocito es la célula mayoritaria de la piel, representa el 90 % de las mismas, el melanocito se encuentra situado en la capa basal en proporción 1/10 m con los queratinocitos. Las células de Langerhans son los macrófagos de la piel y la célula de Merckel es de origen neuroectodérmico que se cree que es un receptor táctil.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes tipos de epiteloma basocelular es más resistente a la radioterapia?:

1. Perlado plano.
2. Superficial o pagetoide.
3. Esclerodermiforme.
4. Pigmentado.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Aunque la radioterapia se usa cada vez menos en la práctica clínica diaria del dermatólogo, este es un concepto clásico en el cáncer de piel, y por tanto imprescindible que lo sepas. El carcinoma basocelular esclerodermiforme representa una gran dificultad diagnóstica y terapéutica. Se presenta como una placa blanquecina con límites poco definidos y consistencia indurada que recuerda a una cicatriz o una placa de morfea. Es difícil de detectar clínicamente si no lo valora un dermatólogo y por lo tanto, suele haber estado presente durante años al momento del diagnóstico. La radioterapia es ineficaz en el tratamiento de esta modalidad de carcinomas basocelulares (opción 3 correcta). Puede ser útil en el resto de tipos en determinadas ubicaciones. Recuerda que actualmente la cirugía micrográfica de Mohs se considera el tratamiento de elección de los carcinomas basocelulares, ya que es la que proporciona una menor tasa de recidivas a los 5 años (1 %). De paso la pregunta te puede servir para repasar las distintas formas clínicas de los carcinomas basocelulares. La forma clínica más frecuente y típica es la opción uno. De hecho, cuando te hablen de una pápula perlada, piensa siempre en carcinoma basocelular. La forma superficial- multicéntrica o Pagetoide se presenta a modo de una placa eritematodescamativa localizada generalmente en tronco, que puede recordar a un eccema. Su límite sobrelevado brillante y la no respuesta a corticoides tópicos te deben hacer pensar en un carcinoma basocelular y no en un eccema. Nódulo- ulcerativo o ulcus rodens es una forma agresiva, con ulceración precoz y rápida destrucción local.

-----O-----

Señale la relación correcta:

1. Glándulas ecrinas-hidradenitis supurativa.
2. Glándulas apocrinas-acné.
3. Glándulas sebáceas-andrógenos.
4. Glándulas sudoríparas ecrinas-fibras parasimpáticas adrenérgicas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La piel recibe una inervación compleja formada por un sistema eferente derivado de la porción simpática del sistema nervioso autónomo (mayoritariamente colinérgico), que inerva la red vascular y los anejos cutáneos. Las glándulas de la piel pueden sebáceas o sudoríparas. Las glándulas sebáceas desembocan en el folículo piloso, su secreción depende principalmente de andrógenos y su patología genera el conocido acné (opción 3 verdadera). Las glándulas sudoríparas pueden ser: ecrinas, (que dependen fundamentalmente de la acetilcolina, se encuentran fuera de la unidad pilosebácea y su oclusión genera la denominada periporitis o sudamina) o apocrinas (que dependen fundamentalmente de la adrenalina, se localizan junto a la unidad pilosebácea en axilas, ingles y región perianal, y su inflamación genera la denominada hidradenitis supurativa).

-----O-----

Un varón de 40 años presenta a los 5 días de un contacto sexual sospechoso una úlcera

en prepucio de borde congestivo, fondo sucio, doloroso y que sangra fácilmente al roce. A la exploración se objetivan adenopatías en la región inguinal derecha, voluminosas y fluctuantes. ¿Cuál es el agente etiológico de esta infección?:

1. Haemophilus ducreyi.
2. Gonococo.
3. Chlamydia trachomatis.
4. Treponema pallidum.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta básica de dermatología. Cuando nos hablen de una úlcera genital de aparición aguda tras un contacto sexual de riesgo tenemos que plantearnos tres causas, por orden de frecuencia, un Herpes genital, un chancro sifilítico y un chancro blando. El herpes genital es la causa más frecuente de úlcera genital, esta causada en el 80% por herpesvirus tipoII, presenta vesículas agrupadas sobre base eritematosa y adenopatías bilaterales dolorosas. El chancro sifilítico es la expresión clínica de la sífilis primaria, es una úlcera de fondo limpio, dura e indolora con adenopatías bilaterales e indoloras también. El chancro blando esta causado por Haemophilus ducreyi, es blando, de fondo sucio y doloroso, con adenopatías unilaterales también dolorosas. Éste último es el caso que nos ocupa, por ello la respuesta correcta es la 1.

-----o-----

Ante un paciente VIH cuyos análisis muestran un leve deterioro inmune, y presenta al examen placas blanquecinas en boca y faringe que se desprenden al rascado dejando una mucosa eritematosa y edematosa al descubierto, ¿cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Leucoplasia oral vellosa.
2. Angiomatosis bacilar.
3. Candidiasis orofaríngea.
4. Infección por herpesvirus.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se nos pregunta por las dermatosis asociadas al VIH, un tema de creciente importancia. Esta pregunta se puede responder por dos vías:

- Se describe a un paciente VIH con un leve deterioro inmune que presenta unas lesiones sugestivas de muguet. La candidiasis se presenta cuando la función inmune es todavía buena, lo que apoya la sospecha diagnóstica.

- Se puede responder directamente, sabiendo que la candidiasis es la dermatosis más frecuente en el VIH, presentándola hasta el 100% de los pacientes en algún momento de su desarrollo. Opción 3 correcta.

-----o-----

La ruptura de los puentes del estrato espinoso es una hallazgo histológico frecuente en el pénfigo. A este hallazgo se le denomina:

1. Paraqueratosis.
2. Disqueratosis.
3. Espongiosis.
4. Acanтолisis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La ruptura de los puentes intercelulares del estrato espinoso se denomina acantolisis. (Acanto = estrato espinoso. Lisis = ruptura), por lo que la respuesta correcta es la 4. La paraqueratosis se define como la presencia de queratinocitos con núcleo en el estrato córneo y es un hallazgo histológico típico de la psoriasis.

La disqueratosis se define como la presencia de queratinocitos “abortivos” en el estrato espinoso y puede verse en múltiples patologías, entre ellas la Enfermedad de Darier. Por último, la Espongiosis es un edema intercelular que suele encontrarse en el eccema.

-----o-----

Paciente mujer de 50 años que presenta cuadro persistente de varios meses de evolución consistente en erosiones dolorosas en la mucosa oral. Se realiza una biopsia de una de las lesiones en la que se observa una hendidura en el espesor de la epidermis junto con la presencia de imágenes de acantólisis. Con respecto a la enfermedad que padece la paciente, señale lo INCORRECTO:

1. En la inmunofluorescencia directa encontraremos IgG depositada en los espacios intercelulares de los queratinocitos
2. En la mayoría de los pacientes, en la inmunofluorescencia indirecta detectaremos en plasma IgG anti-sustancia intercelular de la epidermis (Anti-Desmogleína 3)
3. La afectación mucosa es poco frecuente y la enfermedad no suele debutar en mucosas como en el caso de la paciente
4. Se trata de una enfermedad grave que requiere dosis altas de corticoides u otros inmunosupresores durante períodos prolongados

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se trata del prototipo de pregunta que define a la perfección la frecuente afectación mucosa de esta enfermedad autoinmune que a menudo se acompaña de ampollas flácidas (mas bien EROSIONES) sobre piel sana en pacientes de edad media: el PENFIGO VULGAR. Las respuestas 1, 2 y 4 son correctas. No obstante, la respuesta número 3 es tan falsa que llama la atención, pues la afectación de la mucosa oral a modo de EROSIONES "rebeldes" es la forma inicial de manifestación en la mayoría de los pacientes.

-----o-----

La melanina se sintetiza a partir de:

1. Prolina.
2. Fenilalanina.
3. Serina.
4. Glicina.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta relativamente sencilla y muy directa, que debes saber contestar por conocimientos generales de la carrera. Los melanocitos poseen unos orgánulos, los melanosomas, donde se produce la melanina. Esto es gracias a una enzima, una tirosinasa, que oxida el aminoácido tirosina y, tras otra serie de reacciones, acaba produciéndose la melanina. Lo importante en esta pregunta es saber que el aminoácido precursor de la Tirosina es la Fenilalanina (respuesta 2 correcta). Fallos en esta enzima tirosinasa son los que

originan el Albinismo, en el cual no hay melanina y no existe pigmentación de la piel ni de otros tejidos melánicos.

Cuál de los siguientes fármacos es un inhibidor de BRAF

1. Ipilimumab
2. Pembrolizumab
3. Vemurafenib
4. Cobimetinib

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Opción 3 correcta: Vemurafenib (y dabrafenib) son fármacos de TERAPIA DIRIGIDA (o sea que bloquean señales de "proliferate melanocito y hazte malo"), concretamente inhibidores de Braf. El cometinib también forma parte de la terapia dirigida pero inhibe el MEK.

Ipilimumab y pembrolizumab forman parte de la INMUNOTERAPIA (potencian al sistema inmune para eliminar a los melanocitos "malos"), actúan contra el CTLA4 y PD1 respectivamente.

Una gestante de 31 años y sin antecedentes de interés consulta al inicio del tercer trimestre por una erupción muy pruriginosa, papular y vesiculobullosa de localización periumbilical. Señale la afirmación falsa:

1. El diagnóstico de sospecha de la paciente del enunciado presenta signo de Nikolsky negativo.
2. El fenómeno de Darier es patognomónico de mastocitosis.
3. La enfermedad de Darier suele presentar el fenómeno de Darier.
4. La necrolisis epidérmica tóxica (NET) presenta signo de Nikolsky positivo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El signo de Nikolsky consiste en el desprendimiento de la epidermis al friccionar la piel, reproduciéndose la ampolla o erosión característica de la enfermedad correspondiente. El pénfigo vulgar, la NET y el síndrome de la piel escaldada son enfermedades con signo de Nikolsky positivo. El diagnóstico de sospecha de la paciente del enunciado es de penfigoide gestacional o herpes gestationis, trastorno cutáneo con signo de Nikolsky negativo (ampolla subepidérmica). Así pues, las opción 1 y 4 son verdaderas.

Las lesiones de la mastocitosis presentan un signo diagnóstico y patognomónico, conocido como el signo de Darier, que consiste en que una suave fricción desencadena una reacción urticariforme, con prurito, eritema e hinchazón local, producida por la degranulación de los mastocitos con la consiguiente liberación de mediadores inflamatorios (opción 2 verdadera). Este fenómeno no tiene nada que ver con la enfermedad del mismo nombre (opción 3 falsa). La enfermedad de Darier es una genodermatosis de herencia autosómica dominante, que se presenta como pequeñas pápulas malolientes de color marrón parduzco en áreas seboreicas y afectación ungueal. Su histología consiste en disqueratosis y acantolisis. Suele agravarse con la luz solar.

Una mujer de 56 años, con antecedentes de insuficiencia venosa crónica, acude a su consulta con tumefacción de tercio distal de pierna derecha. Refiere fiebre de 38 °C y afectación del estado general desde hace 4 días, que cede con antitérmicos. A la exploración, destaca la presencia de placa eritematoedematosa en el maléolo y tercio distal de pierna derecha, caliente y muy dolorosa a la palpación, con aspecto en “piel de naranja”. En relación al diagnóstico de sospecha, indique la respuesta correcta:

1. Una buena opción terapéutica sería mupirocina tópica 2 veces al día durante 1 semana.
2. La realización de una eco-doppler de extremidades inferiores nos confirmará el diagnóstico.
3. Se trata de una localización típica, en la que en muchos casos actúa como vía de entrada una lesión banal como una tinea pedis interdigital.
4. Si practicamos hemocultivos, éstos son positivos en un porcentaje elevado de pacientes.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Nos encontramos frente a un caso típico de erisipela / celulitis. La pierna roja, caliente, dolorosa, con "piel de naranja", es sugestiva de ello. Es cierto que el diagnóstico diferencial sería con la TVP, pero en este caso es fácilmente orientable, al no tratarse de un paciente encamado o con problemas de coagulación. La insuficiencia venosa, que predispone a úlceras y heridas, la diabetes, o la presencia de lesiones cutáneas en la zona (o como en este caso señala la respuesta, una tiña interdigital) son habitualmente la puerta de entrada (Opción 3 Correcta). Por último recordar que el tratamiento en estos casos debe ser oral y que los hemocultivos no suelen ser positivos.

-----o-----

Mujer de 68 años con antecedentes de ex fumadora, ganadera de profesión y múltiples carcinomas basocelulares. La paciente acude a nuestra consulta por presentar una nueva lesión costrosa, que “en ocasiones ha sangrado y no termina de curar”, localizada en hemilabio inferior izquierdo. Con respecto al diagnóstico de presunción ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. La aparición sobre lesiones premalignas (queratosis actínicas o leucoplasias) no es infrecuente.
2. Es típica la presentación como pápula perlada con telangiectasias superficiales.
3. Si palpo adenopatías cervicales, podría considerar un escáner como prueba complementaria.
4. El tratamiento de elección es la cirugía.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La respuesta falsa es la opción 2 puesto que dicha presentación clínica se refiere a la típica del basocelular (que como ya se sabe por otra parte, no afecta a mucosas).

-----o-----

¿Qué tipo de fibras vegetativas son las que inervan las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores?

1. Fibras simpáticas adrenérgicas.
2. Fibras simpáticas colinérgicas.
3. Fibras parasimpáticas adrenérgicas.
4. Fibras parasimpáticas colinérgicas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta un tanto imprecisa, ya que no especifica el tipo de glándulas sudoríparas a las que se refiere, apocrinas o ecrinas. Probablemente, el autor de esta pregunta no considera las apocrinas como verdaderas glándulas sudoríparas, en la misma línea de pensamiento que C. Guyton. No obstante, cuando nos preguntan "glándulas sudoríparas y músculos piloerectores", podemos suponer que se refieren a las ecrinas, que son las que comparten inervación con estos músculos. La inervación de las glándulas ecrinas y los músculos piloerectores es simpática. La mayoría de las neuronas simpáticas postganglionares del organismo son adrenérgicas. Sin embargo, existen algunas excepciones, como las glándulas sudoríparas ecrinas, los músculos piloerectores y unos pocos vasos sanguíneos, donde son colinérgicas (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Paciente de 43 años en tratamiento por hiperuricemia con alopurinol que presenta desde hace una semana con un cuadro pseudogripal y la aparición de lesiones eritematovioláceas que presentan una vesícula central, y además lesiones erosivas en mucosa oral. No se observa eritema diseminado por el tronco ni despegamiento epidérmico ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?

1. Eritema exudativo multiforme menor
2. Necrosis epidérmica tóxica
3. Dermatitis herpetiforme
4. Eritema exudativo multiforme mayor

Resp. Correcta: 4

Comentario: La respuesta correcta es la opción 4. En esta pregunta la duda razonable podría plantearse con el eritema exudativo multiforme menor (en el cual nos darían un antecedente de haber sufrido un herpes orolabial los días previos pero NO coincidiendo con las lesiones cutáneas), o la necrosis epidérmica tóxica (el cual se acompaña de importante afectación sistémica y un eritema generalizado con despegamiento epidérmico, recordad el signo de Nikosky).

-----O-----

Mónica es una paciente de 6 años habitual de nuestra consulta. Llevamos siguiéndola desde el nacimiento por la presencia de angiofibromas faciales. Recientemente se le ha realizado una resonancia magnética por un motivo que no viene al caso. En dicha RM se ha observado una imagen compatible con un astrocitoma. Tras realizar una biopsia se confirma que se trata de un astrocitoma de células gigantes. Estos dos elementos que presenta Mónica son muy característicos de uno de los siguientes síndromes. ¿Cuál de ellos es el que MÁS PROBABLEMENTE presenta Mónica?

1. Esclerosis tuberosa.
2. Enfermedad de von Hippel-Lindau.
3. Síndrome de Sturge-Weber.
4. Neurofibromatosis tipo II.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El síndrome que presenta nuestra paciente es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una facomatosis que se caracteriza por presentar angiofibromas faciales, máculas hipopigmentadas lanceoladas,

astrocitomas retinianos, astrocitomas de células gigantes (Opción 1 Correcta).

En el síndrome de Sturge-Weber es característica la presencia de una mancha en “vino de Oporto”.

La enfermedad de von Hippel-Lindau suele presentar feocromocitomas y hemangioblastomas retinianos.

De la Neurofibromatosis tipo II solo debes recordar su asociación con el neurinoma del acústico bilateral.

-----o-----

Acude a su consulta un paciente con lesiones en las manos. ¿Qué diagnóstico es menos probable?

1. Sífilis secundaria.
2. Enfermedad de Kawasaki.
3. Varicela.
4. Fiebre por mordedura de rata.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La localización de las lesiones cutáneas nos puede dar muchas pistas para hacer el diagnóstico. Las enfermedades más “típicas” con afectación cutánea de palmas y plantas son: enfermedad boca-mano-pie, sarampión, Kawasaki, sífilis secundaria, fiebre botonosa mediterránea, fiebre por mordedura de rata... El exantema de la varicela puede localizarse en cualquier zona de piel o mucosas corporales, pero su localización es más frecuentemente centrípeta (zonas medias de tronco, cara y cuero cabelludo), siendo excepcional la afectación palmo-plantar.

-----o-----

La dermatitis herpetiforme se considera la expresión cutánea de la intolerancia al gluten. Con respecto a esta entidad, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La mayoría de los pacientes (90%) presentan clínica de enteropatía sensible al gluten (Enfermedad celíaca), por lo que la ausencia de síntomas digestivos hace improbable el diagnóstico
2. Se presenta en forma de erupción pápulo-vesiculosa muy pruriginosa en planos de extensión y nalgas
3. El hallazgo de depósitos granulares de IgA en el vértice de las papilas dérmicas es típico de esta entidad
4. El tratamiento se basa en dos pilares: dieta exenta de gluten y la dapsona

Resp. Correcta: 1

Comentario: A menudo la dermatitis herpetiforme ("celiquia de la piel") es la manifestación inicial de una futura intolerancia al gluten, por lo que frecuentemente estos pacientes aún no han desarrollado clínica digestiva (respuesta 1 incorrecta). El resto de opciones son correctas. Recordad que puede ser suficiente el control de esta entidad con dieta exenta de gluten (!si podemos evitar dar continuamente la dapsona mejor!).

-----o-----

¿Cuál de las siguientes binomios, fármaco-diana terapéutica, no emplearía en psoriasis?

1. Etanercept-antiTNF.

2. Secukinumab-anti IL 17.
3. Ustekinumab-anti IL 12/23.
4. Dupilumab-anti IL 4/13.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El Etanercept al igual que el Infliximab, el Adalimumab y desde hace poco el Certolizumab son antiTNF aprobados para psoriasis. Dentro de los anti IL 17A tenemos Secukinumab, Ixekizumab y Brodalumab. Dentro de los anti IL 12/23 solo a Ustekinumab, al que hay que sumarle los anti IL 23 (Guselkumab, Risankizumab y Tildrakizumab). Dupilumab es un anti IL4/13 que se emplea para la Dermatitis atópica. (Opción 4 Correcta)

-----o-----

La dermatitis seborreica tiene una clínica típica con eritema y descamación en las denominadas áreas seborreicas: cara (surcos nasogenianos, cejas, orejas), cuero cabelludo, área preesternal y pliegues. Se distinguen dos formas principales de dermatitis seborreica, la infantil y la del adulto. No se ha aclarado todavía si ambas formas constituyen la misma entidad, o bien son dos procesos independientes. El principal diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica infantil es la dermatitis atópica. Se trata de un diagnóstico diferencial de gran interés, debido al mejor pronóstico de la dermatitis seborreica infantil. En este sentido, señale la respuesta FALSA:

1. El sexo masculino es factor de buen pronóstico en el eccema atópico.
2. El eccema seborreico suele localizarse en el centro de la cara y los pliegues.
3. El prurito del eccema atópico suele ser importante.
4. En el eccema atópico puede haber elevación serológica de IgE.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Se trata de una pregunta sencilla gracias al uso de la técnica de examen. Esta clara que la localización del eccema seborreico es en centro de la cara y los pliegues (incluso la propia pregunta te lo recuerda). También que el prurito es un síntoma cardinal e importante en el eccema atópico y que en el eccema atópico, sobre todo en el subtipo extrínseco, suele existir elevación serológica de IgE. Con esto tenemos contestada la pregunta, a pesar de no conocer el detalle de que el eccema atópico es ligeramente de mejor pronóstico en mujeres que en varones y a pesar de que esto sea discutible (Respuesta 1 Falsa).

-----o-----

Señale cuál de las siguientes asociaciones entre alteración histológica y enfermedad cutánea es FALSA:

1. Hipergranulosis: verruga vulgar.
2. Espongiosis: eccema agudo.
3. Acantólisis: pénfigo vulgar.
4. Balonización: urticaria.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Se trata de una pregunta de conocimientos básicos, que no se debe fallar. Existen hallazgos histológicos típicos que debes conocer y manejar con soltura. La Espongiosis, o edema intercelular intraepidérmico, es un hallazgo característico del Eccema agudo. La Hipergranulosis, es decir, el aumento

de la capa granulosa, se produce en las Verrugas vulgares, junto con el aumento de la capa córnea (Hiperqueratosis). La enfermedad de Darier es un trastorno de la queratinización en la que ésta se produce en células aisladas del estrato espinoso (Disqueratosis). La lesión histológica típica del Pénfigo vulgar es la Acanbólisis, es decir, la ruptura de los puentes intercelulares del estrato espinoso, con la aparición de ampollas intraepidérmicas. El Herpes simple es un ejemplo típico de Balonización o edema intracelular de los queratinocitos; sin embargo, la histología de la Urticaria se caracteriza por la aparición de Habones, es decir, zonas de edema intradérmicas en forma de placas eritematosas (respuesta 4 correcta).

-----o-----

Un varón de 70 años acude a su consulta por presentar en dorso nasal una tumoración de 14 meses de evolución cuya exploración física muestra bordes sobreelevados, perlados y ulceración central. La biopsia revela una proliferación celular en la capa basal epidérmica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el pronóstico del paciente?

1. El pronóstico es favorable con cirugía, las metástasis ocurren en un porcentaje moderado-bajo de casos.
2. El pronóstico es excelente con crioterapia, el tratamiento es efectivo y la recidiva infrecuente.
3. Este paciente tiene mal pronóstico aun realizando cirugía.
4. El pronóstico es excelente y las metástasis muy infrecuentes, aunque el paciente puede desarrollar más lesiones consecuencia del daño solar crónico.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Nos presentan a un paciente con un carcinoma basocelular en dorso nasal confirmado con la histología. El pronóstico de este tumor generalmente es excelente (opción 3 falsa), ocurriendo las metástasis de forma excepcional (opción 1 falsa). El tratamiento de elección es la cirugía (opción 2 falsa), como en la mayoría de los tumores de piel. Por lo tanto, la opción verdadera es la 4.

-----o-----

Ante un paciente con manchas pequeñas de color rojo oscuro que no desaparecen a la vitropresión. ¿Debe pensarse en?:

1. Liquen plano.
2. Petequias.
3. Parapsoriasis en gotas.
4. Prúrigo simple agudo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta básica acerca de las lesiones elementales en dermatología. No olvides este concepto. Las petequias son pequeñas manchas del tamaño de la cabeza de un alfiler, que tienen un color rojo, violáceo o negruzco y que no desaparecen a la vitropresión, lo que refleja la existencia de sangre extravasada. Esto las diferencia del eritema cuyas lesiones sí desaparecen con la vitropresión (Opción 2 Correcta). Las petequias pueden deberse a causas parasitarias (picaduras de insectos), mecánicas (mecanismos de succión, pinchazos, etc), infecciones que afecten a la coagulación, enfermedades hepáticas, alteraciones nerviosas como la neuritis, carencias vitamínicas como el escorbuto, etc. Recuerda que en el diagnóstico diferencial de las lesiones purpúricas es importante distinguir la púrpura no palpable (máculas por lesión no vascular como alteraciones plaquetarias o de la coagulación) de la púrpura palpable (pápulas por lesión vascular como las vasculitis).

Le avisan para valorar a un paciente ingresado en la UCI. El paciente presenta lesiones erosivas, ampollas y despegamiento epidérmico en más de un 50% de la superficie corporal, afectando también mucosas. Ante el diagnóstico de sospecha ¿Qué le gustaría averiguar?

1. Los fármacos que ha tomado el paciente, pues sospecha una toxicodermia.
2. Si el paciente ha tenido un herpes la semana previa.
3. Las posibles relaciones sexuales de riesgo.
4. Si algún miembro de su familia tiene la misma clínica, porque se trata sin duda alguna de una patología infecciosa.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Aunque fuese mi vecino y me generase mucha curiosidad sus relaciones sexuales, no cabe duda que nos encontramos ante el cuadro MAS SEVERO de la dermatología, así que seriedad y pensar siempre en una toxicodermia (concretamente la necrosis epidérmica tóxica) (Opción 1 Correcta).

Una chica de 17 años consulta por unos nódulos eritematosos en la región anterior de las piernas, de 2 semanas de evolución. Tiene febrícula, artralgias y le duelen las lesiones. Refiere tomar anticonceptivos orales. Respecto a esta patología, indique lo incorrecto:

1. Afectación predominantemente del septo del tejido celular subcutáneo en la biopsia.
2. La causa más frecuente es desconocida.
3. Observaría vasculitis en la biopsia cutánea.
4. Regresión espontánea de las lesiones.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se trata probablemente de un eritema nodoso, por lo tanto en la biopsia se observaría una paniculitis de predominio septal, sin vasculitis. El resto de opciones son correctas. (Opción 3 falsa)

Un varón de 64 años acude a la consulta por prurito generalizado y la aparición, varios meses antes, de una lesión eritematosa en la espalda, que ha ido extendiéndose y en la actualidad se ha hecho sobrelevada y generalizada. La TC revela afectación ganglionar abdominal y, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, se describe una infiltración por células de aspecto linfocítico, de gran tamaño, con el núcleo "convoluto". El inmunofenotipo demuestra clonalidad a expensas de células CD4 positivas. El diagnóstico más probable es:

1. Mieloma múltiple.
2. Síndrome de Sézary.
3. Leucemia-linfoma de células T del adulto.
4. Linfoma de Burkitt.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La micosis fungoide es un tema bastante rentable, pues se estudia fácilmente y siempre inciden en el mismo tipo de preguntas. Es un linfoma cutáneo de células T, de bajo grado de malignidad, cuya evolución dura muchos años. Clínicamente, evoluciona en tres fases: eccematosa o macular, en placas o infiltrativa y tumoral. Desde el punto de vista histológico, debes recordar los microabscesos de Pautrier, que son cúmulos de linfocitos intraepidérmicos, de aspecto atípico y con núcleo cerebriiforme. En el caso de este paciente, se trata de un síndrome de Sézary, que es la fase leucémica de la micosis fungoide. El síndrome de Sézary se define por la tríada: eritrodermia, linfadenopatías y existencia de más del 10% de células de Sézary en sangre periférica. La célula de Sézary es un linfocito T atípico con núcleo cerebriiforme (Opción 2 Correcta). En pacientes con este tipo de leucemización, el prurito es muy intenso y debes considerarlo un síntoma cardinal.

-----O-----

Mujer de 57 años que acude a su consulta por presentar en el pabellón auricular izquierdo una lesión nodular, costrosa y ulcerada. Recientemente ha sido diagnosticada de carcinoma de ovario, recibiendo un tratamiento quimioterápico agresivo. Una biopsia cutánea muestra queratinocitos atípicos en todo el espesor de la epidermis. Con respecto al diagnóstico de sospecha señale lo verdadero.

1. La localización de nuestra paciente es la de mayor riesgo de afectación ganglionar.
2. Se trata del tumor cutáneo maligno más frecuente.
3. La radiación ultravioleta, inmunosupresión, arsénico y cicatrices o úlceras previas, son también factores de riesgo.
4. La localización en mucosas es excepcional.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se trata de una paciente con un carcinoma epidermoide. El antecedente de quimioterapia agresiva y sus características clínicas e histológicas lo definen. Recordad que no es infrecuente la localización en mucosas (opción 4 falsa) siendo el labio la localización de mayor riesgo de afectación ganglionar (opción 1 falsa). El carcinoma epidermoide es el segundo tumor cutáneo maligno más frecuente tras el basocelular (opción 2 falsa). La respuesta correcta por tanto es la opción 3.

-----O-----

¿Cuál es el nombre de la lesión elemental, sólida e inflamatoria, de tamaño superior a 1 cm. situada en la dermis o hipodermis y que al curar cicatriza de manera no visible?

1. Pápula.
2. Pústula.
3. Nódulo.
4. Habón.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta básica, que no se debe fallar, sobre la Clasificación de las Lesiones Elementales, cuyos conceptos debes manejar sin ninguna duda. Esta definición corresponde a un Nódulo (respuesta 3 correcta). Una Mácula es una lesión pigmentada, que no hace relieve, menor de 1 cm. Una elevación sólida menor de 1 cm, palpable, es una Pápula. Una pequeña vesícula con contenido purulento es una Pústula. Por último, un Habón es una placa dérmica edematosa y con eritema, que desaparece en menos de 24 horas.

-----O-----

Respecto al eritema exudativo multiforme menor, señale la correcta:

1. Siempre afecta a mucosas
2. Aparece normalmente a la semana, tras una infección de herpes simple
3. Tiene una alta mortalidad
4. Cursa con fiebre de más de 39°C

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las lesiones cutáneas del eritema multiforme menor suelen tener como antecedente en los días previos un herpes orolabial. No obstante no es así en todos los casos (respuesta 1 falsa) . La clínica sistémica es infrecuente (opción 4 falsa) así como la mortalidad prácticamente nula (opción 3 falsa). Estas dos últimas opciones se refieren mas probablemente a un eritema multiforme mayor o una necrolisis epidérmica tóxica. La opción correcta por lo tanto es la 2.

-----O-----

Varón de 30 años con lesión hiperpigmentada de bordes irregulares de tiempo incierto de evolución. A la dermatoscopia presenta retículo atípico, varios colores y bordes irregulares. Ante el diagnóstico de sospecha ¿Cuál será su primera actuación?

1. Solicitar un estudio genético del ocogen BRAF
2. Biopsia con punch de una región de la lesión
3. Extirpación con márgenes de 1 cm
4. Biopsia excisional

Resp. Correcta: 4

Comentario: Ante la sospecha de melanoma debemos hacer inicialmente una biopsia EXCISIONAL (es decir, quitar toda la lesión pigmentada, sin márgenes de 1 o 2 cm ni nada de esto, pues tendremos que confirmar en anatomía patológica que se trata de un melanoma y entonces ya veremos los márgenes y si está indicado o no hacer ganglio centinela) (Opción 4 Correcta). Importante, diferenciar biopsia incisional (me llevo una parte de la lesión, a esto se refiere la opción 2) de biopsia excisional (me llevo toda la lesión).

-----O-----

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) debe conocerse bien, hoy más que nunca, y para ello es fundamental la morfología lesional de piel y mucosas. ¿Qué dermatosis es de las más frecuentes y características?:

1. El liquen plano.
2. La pitiriasis rubra pilar.
3. El chancro venéreo o blando anal.
4. La dermatitis seborreica.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta de dificultad intermedia perteneciente al tema de patología infecciosa asociada al VIH. La dermatitis seborreica es una enfermedad eritematodescamativa ya de por sí muy frecuente, llegando en el caso de los VIH a ser la dermatosis no infecciosa más predominante (Opción 4 Correcta). Se caracteriza por tener una distribución típica en cuero cabelludo, región centrofacial, axilas, ingles y línea

media del tronco. Se asocia como agente infeccioso al *Pityrosporum ovale*, aumentando su prevalencia en ciertas patologías como ACV, enfermedad de Parkinson, alcoholismo, y SIDA. En cuanto al tratamiento, suelen emplearse antifúngicos y corticoides suaves tópicos.

Un varón de 48 años acude a su consulta por la aparición de una lesión en el ala nasal derecha. Aporta informes de alta de intervenciones quirúrgicas previas sobre esa zona en los cuales puede leer en el apartado de anatomía patológica que se trataba de un epiteloma basocelular de patrón infiltrativo. Usted percibe mucha ansiedad en el paciente, ya que se le ha intervenido previamente en 2 ocasiones en esa área, ocasionándole una distorsión anatómica considerable. Debido a la aparente complejidad del caso, usted decide realizar una interconsulta al dermatólogo. El especialista en este caso elegirá una de las siguientes opciones terapéuticas:

1. Terapia tópica con imiquimod.
2. Terapia fotodinámica.
3. Cirugía micrográfica de Mohs.
4. Radioterapia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta sobre el cancer cutáneo no melanona, concretamente sobre el epiteloma basocelular. En este tipo de tumores el tratamiento de elección es siempre quirúrgico, con una serie de precisiones. En basocelular superficial podría utilizarse también el imiquimod o la terapia fotodinámica como alternativas (en este caso al ser infiltrativo, estas dos opciones están completamente descartadas). La radioterapia puede ser una alternativa para aquellos pacientes cuyo tumor sea irresecable (y convertirlo así en resecable) o para aquellos paciente, en lo que por comorbilidades (normalmente pacientes mayores) sea menos agresiva la radioterapia que una cirugía. La radioterapia, en cambio, no estará indicada en pacientes jóvenes o en aquellos casos en los que se trate de una recidiva, pues la cicatriz dificultará el buen resultado de la radioterapia. En recidivas y tumores invasivos, será de elección la cirugía y dentro de esta la cirugía de Mohs, pues al ser una cirugía con control de márgenes, reduce el riesgo de una nueva recidiva (Opción 3 Correcta).

Señale la FALSA respecto al tratamiento de la psoriasis y el liquen plano:

1. El uso de corticoides sistémicos debe evitarse siempre que se pueda porque tras su retirada se puede desencadenar un brote psoriásico más grave.
2. En psoriasis moderadas o severas se debe instaurar tratamiento con fármacos biológicos de primera elección.
3. El tratamiento de elección en brotes de psoriasis leves son las cremas emolientes, queratolíticos, corticoides tópicos, análogos de la vitamina D y retinoides tópicos.
4. En casos graves de liquen plano están indicados los corticoides sistémicos.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Podemos plantear la pregunta de la siguiente manera, ¿Te gastarías COMO PRIMERA ELECCIÓN cientos de euros mensuales en un paciente con psoriasis moderada que aún no ha probado fototerapia u otros sistémicos?. Esta claro ¿no? El sistema sanitario se hundiría en cuestión de días. Por lo tanto, la opción incorrecta es la 2. El resto de opciones son correctas. Recuerda que en el liquen plano tenemos una gran variedad de tratamientos (entre ellos los corticoides sistémicos para casos graves, los cuales

NO debemos usar nunca en la psoriasis).

-----O-----

Varón de 78 años con antecedentes de alcoholismo y deterioro cognitivo, vive solo en su domicilio. Es traído al hospital por presentar un cuadro de reagudización de su insuficiencia renal secundario a una diarrea. A la exploración física presenta una piel apergaminada con un eritema en zonas fotoexpuestas así como en cuello unas máculas y pápulas hiperpigmentadas eritematodescamativas de bordes bien definidos. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Déficit de zinc.
2. Déficit de vitamina B3.
3. Déficit de vitamina C.
4. Déficit de B12.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla si reconocemos la clínica de la pelagra: las 3D (Diarrea, Demencia, Dermatitis) debida al déficit de niacina (vitamina B3, ácido nicotínico o niacina) (opción 2 verdadera). En nuestro medio este cuadro se asocia típicamente al alcoholismo y anorexia (malnutrición). La dermatitis es característicamente fotosensible con pápulas eritematodescamativas en cuello (collar de Casal) así como una piel apergaminada (*pelle agra*=piel áspera). El tratamiento se basa en la fotoprotección y reposición de ese déficit administrando niacina. El resto de opciones son incorrectas, pues el déficit de zinc produce acrodermatitis enteropática, el déficit de vitamina C produce el escorbuto, y el déficit de B12 hiperpigmentación generalizada.

-----O-----

El glioma de nervio óptico aparece en un síndrome neurocutáneo de forma típica. Señálelo:

1. Neurofibromatosis tipo 1.
2. Esclerosis tuberosa .
3. Síndrome de Sturge-Weber.
4. Enfermedad de von Hippel-Lindau.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Se trata de una pregunta directa muy sencilla sobre las facomatosis. De estas enfermedades debes recordar, además de sus manifestaciones cutáneas, las neurológicas (especialmente), ya que pueden ser objeto de pregunta tanto en dermatología como en neurología. En este caso, la opción correcta es la 1, neurofibromatosis tipo I, caracterizada por: afectación familiar, 6 o más manchas café con leche, 2 o más neurofibromas o neurofibromas plexiformes, efélides axilares o inguinales, 2 o más hamartomas de Lisch (hamartoma del iris), glioma óptico, alteraciones óseas. Página 40. Manual CTO 4ª Edición

-----O-----